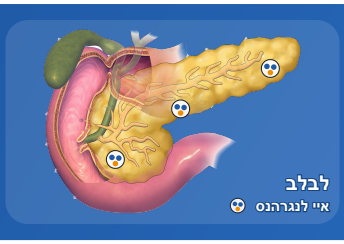
סוכרת

מאזן הסוכר · המחלה והטיפול · מצבי חירום

דף סיכום · 3 חלקים · פודקאסטים קלוד



חלק 1 · מאזן הסוכר

שובע · אינסולין

מתאי **ביתא** · פותח GLUT-4 ← סוכר נכנס לתאים · ממלא את המחסן

רעב · גלוקגון

מתאי **אלפא** · מפרק את המחסן בכבד ← סוכר לדם

לא להתבלבל: גליקוגן = המחסן · גלוקגון = המפתח למחסן · אינסולין ממלא את המחסן

ואם הרעב נמשך?

עד כעשר שעות **גליקוגנוליזה** (פירוק המחסן) ← **גלוקונאוגנזה** (גלוקוז חדש מחלבונים) ← במקביל פירוק שומן ל**גופי קטו**: מזינים את המוח, אבל חומציים.

חשוב לשטח: המוח (GLUT-3) לא צריך אינסולין ותלוי בגלוקוז, ולכן סוכר נמוך = תסמינים נוירולוגיים. טווח תקין: 60–100 mg%.

חלק 2 · המחלה והטיפול

סוג 1 · כ-10%

לרוב אוטואימוני: תאי הביתא נפגעים · צעירים · אינסולין מההתחלה

סוג 2 · כ-90%

תנגודת לאינסולין · מבוגרים · הלבלב מתעייף עם השנים

שימו לב: סוג 2 שמזריק אינסולין = לבלב מותש, מחלה מתקדמת, וסיכון גבוה יותר להיפוגליקמיה.

איך מאבחנים ועוקבים?

סוכרת: צום מעל 126 · אקראית מעל 200 · העמסה (שעתיים) 200 ומעלה. **HbA1c** = ממוצע של כשלושה חודשים · יעד בחולים: מתחת ל-7%.

מה על השיש?

סוחטי לבלב (אמריל, גלובן) ← **היפוגליקמיה** · נובונורם: קצרה, פחות היפו · מטפורמין (גלוקומין): מעכבת את המפעל בכבד · **gliptin** = מעכב DPP-4 (טרג'נטה, ג'נוביה; ג'נואט = + מטפורמין) · אינסולין מהיר ← **היפוגליקמיה**

כמו: GLP-1 = שליח שמביא הודעה ללבלב, DPP-4 = החותך שמשמיד אותה. מעכב DPP-4 עוצר את החותך.

בשטח: מודדים אחרי מים וסבון וייבוש (באלכוהול מחכים לייבוש מלא) · CGM יוצא מכיול ← מכשיר ידני לגיבוי · בחולה סוכרת, תלונה עמומה יכולה להיות אוטם שקט.

חלק 3 · מצבי חירום

מתחת ל-60

היפוגליקמיה (מד"א)

Lo

במכשיר: מתחת ל-20

Hi

במכשיר: מעל 500

איך נראית היפוגליקמיה?

בלבול, עצבנות, תוקפנות ← עד קומה · פרכוסים · **חסר נוירולוגי שנראה כמו שבץ** · דופק מהיר, הזעה, חיוורון.

בודקים סוכר: בכל שינוי בהכרה, חשד לשבץ, פרכוס או פוסט איקטלי (גם פרכוס חום), ובחולה סוכרת עם בלבול, רעד או הזעה.

מד"א: טיפול בהיפוגליקמיה

1. מזמינים ALS בכל היפוגליקמיה או שינוי בהכרה
2. בהכרה מלאה: גלוקוג'ל לפה
3. מעורפל: על הצד, אגד או מנתב בין השיניים, גלוקוג'ל על החניכיים ומתחת ללשון, פינוי בלי עיכוב
4. בדיקה חוזרת: עדיין מתחת ל-60 ← שפופרת נוספת
5. ALS: משאבה? מנתקים · גלוקוז 25 IV גרם בריכוז 25%, וריד גדול, שטיפה לפני ואחרי
6. אחרי 5 דקות עדיין מתחת ל-60 ומעורפל ← חצי מנה

DKA

כמעט אין אינסולין · מהר (שעות עד יממה) · 300–600 · קטונים וחמצת · הקאות, כאבי בטן, ריח אצטון, **קוסמאול** · לרוב סוג 1

HHS

מעט אינסולין · לאט (ימים עד שבועות) · 600–1200 · בלי קטונים · **התייבשות קשה** **מאוד** · מבוגר, סוג 2, הפסיק תרופות

בשטח, בשניהם: ABC · חמצן · נוזלים בבולוסים עם מעקב מדדים (המועדף: הרטמן) · לא ביקרבונט · פינוי.

שימו לב: DKA: להימנע מהנשמה, אלא כמוצא אחרון. הנשימות העמוקות מפצות על החמצת, והנשמה עלולה לגרום לקריסה.

3 דברים לזכור

1. **היפוגליקמיה = מתחת ל-60: גלוקוג'ל, או גלוקוז 25 גרם בריכוז 25%**
2. **בודקים סוכר בכל שינוי הכרה, חשד לשבץ ופרכוס**
3. **DKA מהיר עם קטונים וקוסמאול · HHS איטי עם התייבשות קשה**

מקור: התסריטים של הסדרה (מצגת הקורס והאוגדן). הדף חומר לימוד ואינו מהווה תחליף לפרוטוקול מד"א המעודכן. איורים: מקוריים, בסגנון הסרטון. איור הלבלב (מעובד): Blausen Medical, CC BY 3.0, ויקישיתוף.